

SUJET

Accès aux soins en Île-de-France : où agir en priorité ?

Tableau de bord d'aide à la décision pour les élus locaux

SAKOA Etia-Anaëlle — M2 Data Science



Made with GAMMA



PROBLÉMATIQUE

L'accès aux soins se dégrade — particulièrement en Île-de-France

Les élus sont en première ligne, mais sans outil pour mesurer le besoin sur leur territoire.

Une offre médicale qui recule

moins de médecins, des départs en retraite non remplacés

Écarts énormes

entre communes voisines d'un même EPCI

Manque d'outil d'aide à la décision

pour prioriser les actions localement

Sources

ARS Île-de-France, Étude démographique médecins généralistes (janvier 2022)

Fédération Hospitalière de France x Ipsos BVA, Baromètre accès aux soins (mars 2026)

Sondage Odoxa pour ARS Île-de-France (décembre 2024)

CONSTATS

3 chiffres clés

Ces trois indicateurs montrent à quel point l'accès aux soins est déjà sous tension en Île-de-France, avec des écarts marqués entre territoires et un enjeu de renouvellement des médecins.

62%

Communes franciliennes sous-dotées

des communes franciliennes sous-dotées en généralistes

13x

Écart de densité en dermatologie

plus de dermatologues à Paris qu'en Seine-Saint-Denis

52,8

Âge moyen des médecins
ans en moyenne — départs en retraite massifs à anticiper

QUESTIONNEMENT

Deux niveaux de décision

Où agir ?

Vue président·e d'EPCI

Comparer les communes du territoire et repérer les plus tendues.

Sur quoi agir ?

Vue maire

Pour ma commune, quels indicateurs décrochent par rapport à la moyenne régionale ?

SOURCES

Sources ouvertes, officielles, croisées par commune



APL généralistes 2023

DREES — accessibilité par habitant, niveau commune



Densité 4 spécialistes

DREES/RPPS — cardio, dermato, ophtalmo, gynéco pour 100 000 hab.



Âge moyen des médecins

DREES 2025 — anticipation des départs en retraite



Périmètre territorial

INSEE + BANATIC — 1 266 communes, rattachement EPCI, population

SCORE

Un score de tension unique par commune

Chaque commune reçoit un score de 0 à 100 basé sur trois indicateurs égaux.

Généralistes

APL

Spécialistes

Densité

Âge moyen des médecins

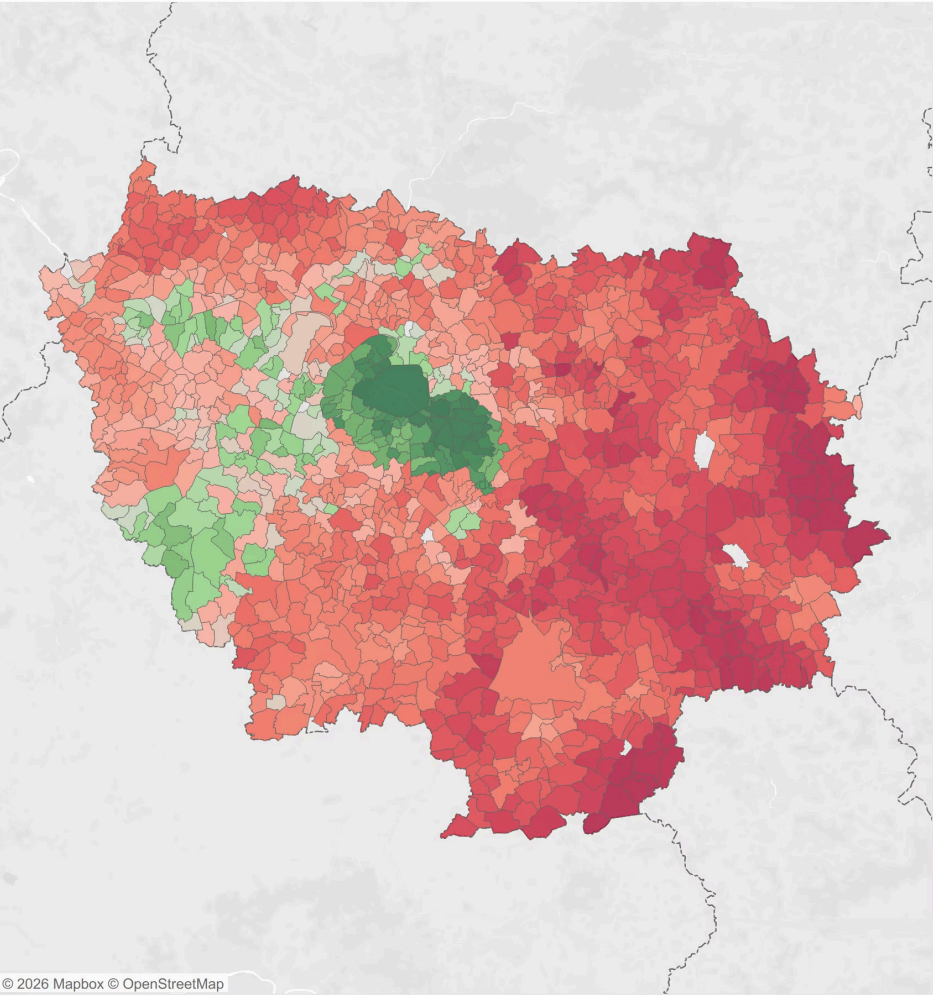
Résultat : un score unique qui permet de comparer et prioriser

Écart observé : de **17 à 93 points (0-100 normalisé)**

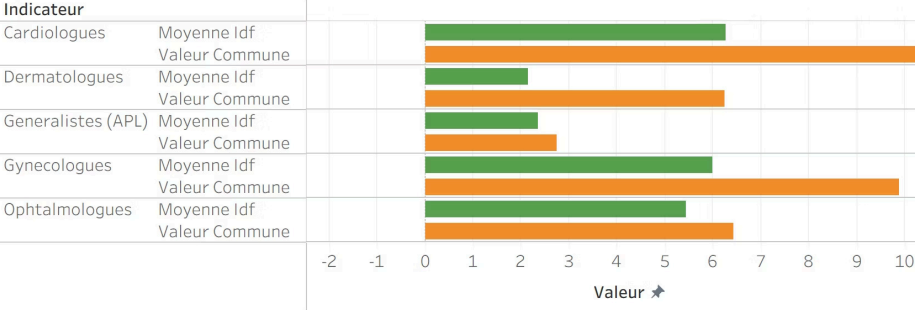
Un tableau de bord en deux vues complémentaires

Publié sur **Tableau Public**, accessible depuis n'importe quel navigateur — sans installation.

Carte EPCI



Ma commune vs moyenne IDF



Carte EPCI

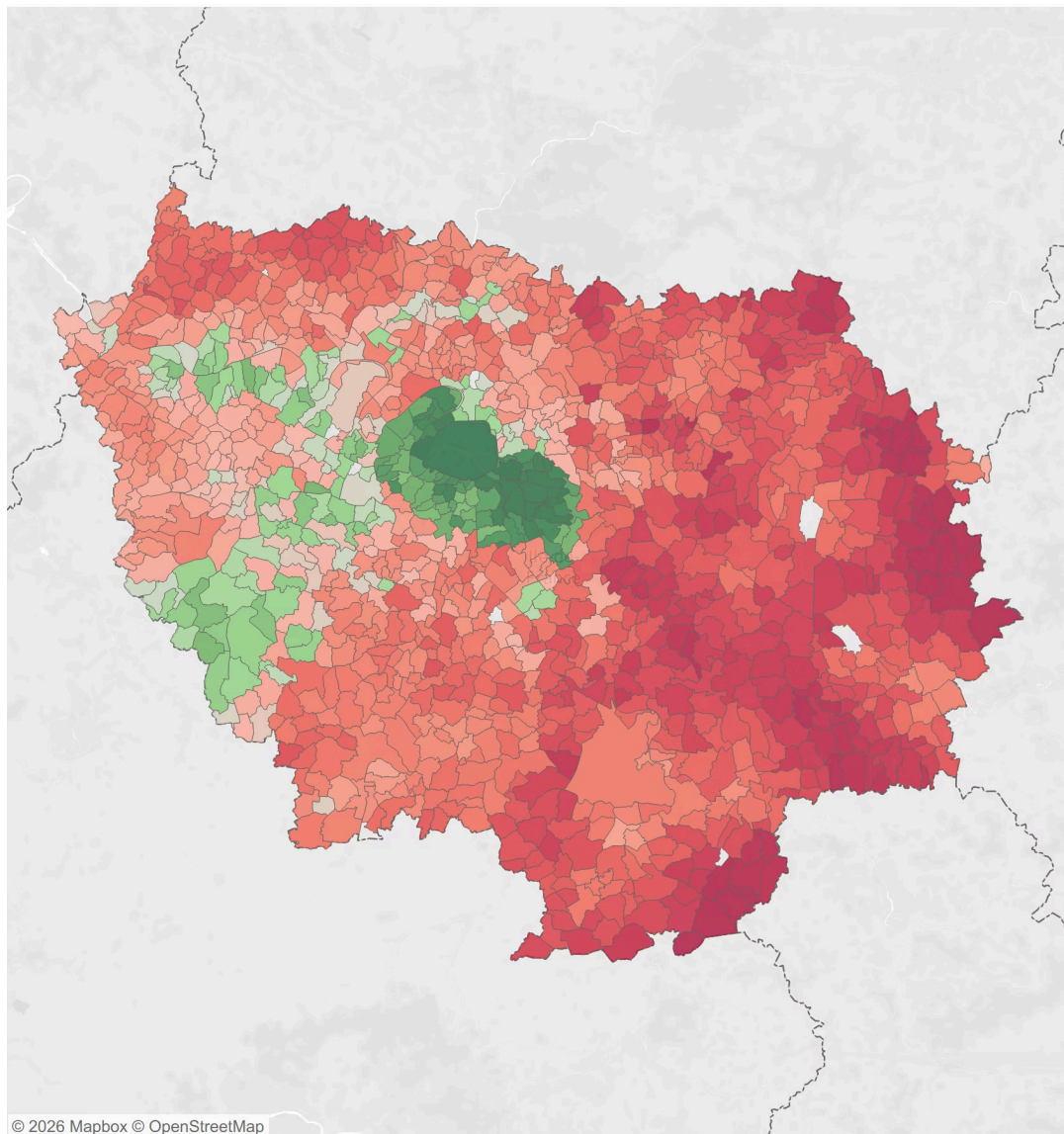
Vue territoriale : visualiser toutes les communes de l'EPCI, identifier les zones prioritaires et comparer les niveaux de tension

Profil commune

Vue locale : analyser en détail une commune, voir quels indicateurs (généralistes, spécialistes, âge des médecins) posent problème

Où agir — La carte EPCI

Carte EPCI



Comment l'utiliser ?

Le président·e d'EPCI filtre son territoire et identifie immédiatement les communes les plus tendues.

- **Rouge** = priorité d'intervention
- **Vert** = commune bien dotée
- **Comparaison instantanée** entre communes voisines

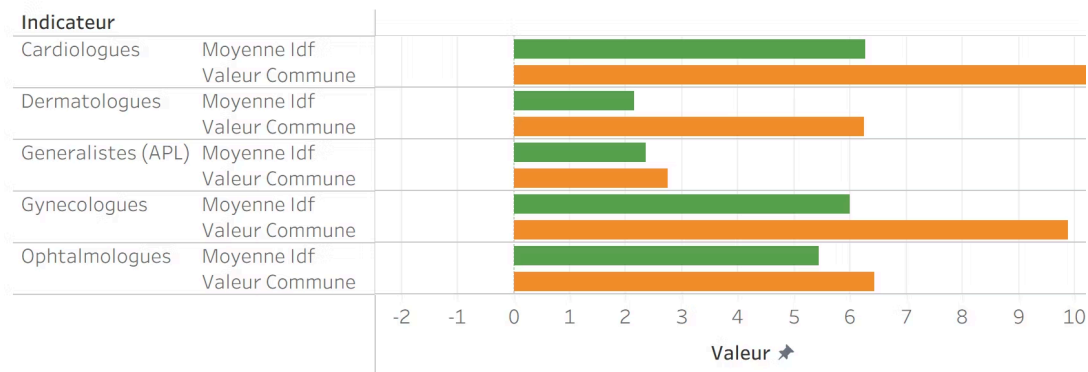
Sur quoi agir — Le profil commune

Ce que ça montre

Pour une commune choisie, chaque indicateur est comparé à la moyenne régionale. On voit immédiatement ce qui décroche.

- **APL généralistes vs moyenne Île-de-France**
- **Densité par spécialité**
- **Âge moyen des médecins locaux**

Ma commune vs moyenne IDF



Démonstration

En direct

Accéder au tableau de bord



Made with GAMMA

Les difficultés rencontrées

Ce qui a été le plus dur à construire

Croiser des sources hétérogènes

Problème : J'ai dû réconcilier la DREES, le RPPS, l'INSEE et BANATIC, qui n'avaient ni les mêmes formats ni les mêmes codes.

Solution : J'ai tout recollé commune par commune avec le code INSEE.

Des données pas toutes à jour

Problème : Je n'avais pas une année commune pour toutes les sources.

Solution : J'ai pris le millésime le plus récent pour chaque indicateur et je l'ai assumé clairement.

Le cas de Paris

Problème : L'APL n'existait que par arrondissement, pas pour Paris entier.

Solution : J'ai reconstruit Paris comme une seule commune, en moyenne pondérée par la population.

Densité des spécialistes au département

Problème : Cette donnée n'existait pas à l'échelle communale.

Solution : Je l'ai approximée au niveau départemental, en assumant cette limite.

Construire un score à partir d'unités différentes

Problème : L'APL, les densités pour 100 000 habitants et l'âge ne s'additionnaient pas.

Solution : J'ai tout ramené sur une échelle de 0 à 100, puis j'ai inversé les indicateurs d'offre.

COLLABORATION

Pourquoi nous faire confiance ?



Prioriser avec confiance

Des données officielles et transparentes pour appuyer vos choix.



Agir sur les bons leviers

Identifier précisément ce qui décroche pour cibler vos actions.



S'adapter au contexte

L'outil fonctionne pour votre EPCI ou votre commune.



Prêt à l'emploi

Accessible en ligne, sans installation — utilisable immédiatement par vos équipes.

CONCLUSION

Conclusion

Un outil simple pour aider les élus à agir.

Des données ouvertes, une méthode transparente, deux niveaux de lecture pour prioriser les actions sur l'accès aux soins.

Merci de votre attention.

Vos retours et vos questions sont précieux pour améliorer cet outil et l'adapter à vos besoins réels.